

Neuro.

1. Une femme de 92 a chuté en étant seule chez elle. Elle est emmenée à l'hôpital avec une écorchure. Après 3 jours d'hospitalisation, l'infirmier remarque un **tremblement rythmique** de sa **main gauche**. La patiente réagit adéquatement quand on lui parle, elle est orientée.

De quoi viennent le plus probablement ces tremblements ?

- A. Dystonie
- B. Tremor idiopathique
- C. Frissons
- 4.** Tremor dus à un parkinsonisme
- 5. Épilepsie focale

Infection

11. Patient de 53 ans, suivi pour un **VIH** mais qui ne prends plus ses traitements depuis plusieurs mois (crise de vie de la cinquantaine). Taux de **CD4 à 210**, il se présente avec **toux sèche, fatigue, dyspnée**. A l'auscultation râles des deux côtés, la gazo montre un taux d'oxygène à 65mmHg. La Rx montre un infiltrat bilatéral.

- A. Pneumonie à CMV
- B.** Pneumonie à Pneumocystis Jiroveci
- C. Toxoplasmose pulmonaire
- D. Syndrome de Kaposi
- E. Méningite à ...

Obstétrique

15. Une jeune femme de 25 ans est amenée en salle d'accouchement pour un accouchement par voie basse. On suspecte chez elle une **pré-éclampsie**. On décide de traiter son hypertension artérielle et son antalgie par anesthésie locale. Où faut-il lui administrer l'anesthésique local?

- A. Sous la dure-mère
- B.** Dans l'espace péri-dural
- C. Dans l'espace sous-dural
- D. Dans l'espace sous-arachnoïdien
- E. Dans le liquide céphalo-rachidien

Gynéco.

18. Une femme de 65, **ménopausée** se présente en consultation ambulatoire de gynécologie en raison de **pertes sanguines vaginales indolores** depuis 1 semaine. Elle est connue pour un **diabète de type 2**, une **hypertension artérielle** et un **BMI à 35**. L'examen clinique est normal. L'examen gynécologique montre un **col lisse et calme**. L'échographie endovaginale montre un **épaississement de l'endomètre** de 5 mm. Quelle est la prochaine étape diagnostique?

- A. Traitement hormonal substitutif
- B.** Biopsie de l'endomètre
- C. Contrôle biologique : TSH, LH, FSH
- D. CT pelvis
- E. Contrôle de la crase

car ménopausée et endomètre > 4 mm (et > 45 ans)

Neuro.

19. Patient de 63 ans qui se présente aux urgences pour une dyspnée. La patiente se dit très fatiguée depuis plusieurs années. La patiente vous semble très asthénique. Elle décrit une impression de perte de force aux 4 membres qui aurait débuté par le bras droit. Au status vous relevez une amyotrophie des muscles interosseux au niveau des deux membres supérieurs. Une faiblesse M3-M4 au niveau des membres supérieurs ainsi qu'une faiblesse plus marquée aux membres inférieurs. Des fasciculations sont observables. Vous mettez en évidence une hyperréflexie au niveau rotulien ainsi qu'en achilléen. Le Babinski est en flexion ddc (sûr de ça???).

Quel examen est indiqué afin de poser le diagnostic suspecté ? = SLA

- A. Electroneuromyographie
- B. IRM cérébral et médullaire
- C. Ponction lombaire
- D. Ct
- E. Electromyographie

Neuro.

21. Un homme de 48 ans, sans antécédent particulier se présente aux urgences pour une vision double dans le sens vertical apparue brutalement il y a une semaine. La vision double est présente de manière constante et péjorée quand le patient regarde en bas à gauche. Quelle est l'atteinte la plus probable ?

- A. Diplopie myasthénique
- B. Paralyse du n. Abducens à gauche
- C. Paralyse du n. Trochléaire à droite = n. IV droit
- D. Lésion du m. droit supérieur à droite
- E. ...



Péd.
(Chir.)

25. Enfant de 6 ans, vient en consultation chez vous avec sa mère. Elle a remarqué une voussure inguino-scrotale à D, non douloureuse qui est plus marquée le soir. A l'examen clinique le testicule D est plus grand que le gauche, les 2 testicules sont palpables, et le D est positif à la transillumination.

Quel est le diagnostic le plus probable?

- a. Torsion testiculaire
- b. Hydrocèle
- c. Varicocèle
- d. Spermatocèle
- e. Hernie inguinale directe

Chir.
viscéral

32. Patient de 40 ans, s/p appendicectomie il y a 25 ans, arrive aux urgences pour douleurs abdominales. Au status l'abdomen en ballonné, les bruits diminués. Au labo, leucocytose à 13G/l et CRP 40. A l'imagerie on voit un saut de calibre de l'intestin grêle en FID et une lame de liquide libre pelvienne. Quelle est la prise en charge à initier?

- A. Perfusion d'ocrotéotide
- B. Laparoscopie

Il s'agit d'une ileus mécanique sur bride car suspicion de strangulation

- C. Sonde naso-gastrique
- D. Perfusion de NaCl et antidouleurs

Psy.

33. Un patient de 33 ans informaticien de profession vous consulte car a toujours eu des problèmes relationnels. Il a souvent changé de copines et les relations se finissent mal. Adolescent, il a commis de petits délits (vols, vandalisme..) dont certains l'ont fait faire qqes séjours en prison. Récemment, après une dispute avec son employeur, il a démissionné et se retrouve sans emploi.

A votre consultation, il est calme collabore et désire vraiment se soigner car il a une nouvelle petite amie

- a. Personnalité borderline → ♀ +++
- b. Trouble de l'adaptation avec comportements déviants
- c. Personnalité ~~dys~~ sociale anti-sociale → ♂ +++
- d. Personnalité histrionique
- e. Maniaco-dépressif

Neuro.

24. Une patiente de 78 ans consulte car elle se sent moins bien depuis 2-3 semaines. Elle présente des céphalées et des difficultés à avaler. Elle a déjà perdu 4 kg, par contre elle arrive à boire. Elle rapporte également plusieurs épisodes de perte visuelle intermittente d'un oeil depuis quelques jours. La vitesse de sédimentation est de 80 mm/h (norme < 10 mm/h). → Horton

Que faut-il faire au plus vite ?

- A. Biopsie de l'artère temporale
- B. Mise en place d'une alimentation parentérale
- C. Référer au rhumatologue
- D. IRM
- E. Administrer de la cortisone à haute dose

Radio.

29. Un patient de 56 ans, chez qui on suspecte un anévrisme cérébral, connu pour un diabète de type II traité par metformine. Il a également une allergie aux crevettes. On aimerait lui faire un angio-CT. Sa fonction rénale est normale.

Concernant l'injection au produit de contraste iodé, quelle réponse est correcte:

- A. Stopper son traitement de metformine après le CT
- B. Donner de la cortisone en précaution de l'examen
- C. Le CT au contraste iodé est contre-indiqué car il présente une allergie aux crevettes
- D. Faire un CT au contraste iodé sans prendre de précaution

chir. viscéral

38. Un informaticien de 23 ans, en bonne santé habituelle, consulte les urgences pour une douleur épigastrique apparue brusquement il y a 4 heures. La douleur est transfixiante et irradie secondairement dans tout l'abdomen. A l'examen clinique, patient afébrile avec abdomen de bois.

- A. Diverticulite sigmoïdienne
- B. Rupture disséquante de l'aorte** *sur Marfan ?*
- C. Perforation d'un ulcère duodénal
- D. Rupture d'un kyste hépatique d'échinococcose

Psy. 41. Une patiente de 56 énumère à son médecin généraliste ses symptômes présents depuis 10 ans. Elle n'arrive pas à se détendre, présente des troubles du sommeil et s'inquiète beaucoup, ce qui a impacté sa relation avec ses enfants. Maintenant âgée de 22 et 25 ans, ces derniers ont quitté le domicile. La patiente les appelle chaque jour environ 4 fois et s'ils ne répondent pas elle rappelle jusqu'à obtenir une réponse. Ses enfants lui ont demandé d'arrêter d'appeler si souvent et lui ont proposé d'appeler une fois par jour seulement. La patiente sait que les autres mères n'appellent pas leurs enfants si souvent, mais elle n'arrive pas à s'en empêcher car elle s'inquiète trop.

Quel est le diagnostic le plus probable ?

- A. Agoraphobie
- B. Trouble anxieux généralisé**
- C. Épisode dépressif
- D. Trouble obsessionnel
- E. Phobie sociale

Psy. Gynéco. 47. Patiente post-partum depuis 6 semaines, accouchement par voies basses instrumentalisé par forceps qui a duré 6 heures, sans complication, mais dont elle garde un mauvais souvenir. Elle se plaint depuis 2 semaines d'une fatigue, de peine à trouver le sommeil et de tristesse. Elle rapporte avoir peur de ne pas réussir à s'occuper de son bébé ce qui l'angoisse et la fait se sentir coupable.

Quel est le diagnostic ?

- A. Maternity blues
- B. Trouble de l'adaptation
- C. Trouble bipolaire
- D. Episode de stress post-traumatique
- E. Dépression du post-partum**

Rhumato. 48. Patiente de 45 ans, d'origine africaine, atteinte d'une sclérodémie limitée à la peau (limited cutaneous systemic sclerosis), vient consulter pour une dyspnée en progression depuis 1 mois. La radiographie du thorax est sans particularités.

Quelle est la cause de sa dyspnée ?

- A. Hypertension pulmonaire** *sclérodémie cutanée diffuse → fibrose pulmonaire*
- B. Embolie pulmonaire
- C. Diminution de l'ampliation thoracique
- D. Myocardite

Pharmac. 51. Patient de 73 ans avec un cancer pulmonaire présente des douleurs lombaires qui révèlent la présence de métastases osseuses au niveau vertébral. Vous introduisez un traitement

antalgique par **Paracétamol** 1g 3x/jour et **Morphine** SC 5mg 4x/heure. À quoi devez-vous penser suite à l'introduction de ces médicaments?

- A. Introduire un laxatif en prévention pour la constipation
- B. Doser les enzymes hépatiques une fois par jour pour le risque d'hépatotoxicité du Paracétamol
- C. Effectuer un MMS (Mini Mental State) une fois par jour pour le risque de trouble cognitif des opiacés
- D. Introduire une alimentation riche en sel en vue d'une SIADH (syndrome de sécrétion inappropriée d'hormone anti-diurétique) causée par la Morphine

Chir. viscérale
52. Patiente de **77 ans**, fumeuse, consulte aux urgences en raison de douleurs abdominales. Elle décrit des **douleurs épigastriques depuis 5 jours**, d'abord épisodiques et survenant principalement **après les repas**. Elle a **perdu 5 kg** depuis 2 semaines. Actuellement, elle se plaint de **douleurs épigastriques importantes et continues**. Elle n'a pas eu de vomissements ou de diarrhées.

Status : Abdomen sensible mais sans défense ni détente.

Labo : Leuco à 19 G/L, lactate à 4

Quel est l'examen complémentaire à organiser ?

- A. Colonoscopie
- B. Gastroskopie
- C. US-Abdo
- D. Ct-scan injecté de l'abdomen

→ Ulcère gastrique

Dermato.
53. Une patiente de 33 ans en bonne santé habituelle est dans sa 18ème semaine de grossesse et se plaint d'une lésion cutanée sur la cuisse. Elle avait à cet endroit déjà un grain de beauté, mais il a depuis perdu en couleur et saigne de temps à autres. À l'examen clinique, on note une lésion de 8mm de diamètre avec des bords irréguliers.

Que faites vous ?

- A. Un PET-CT
- B. Une IRM de la cuisse
- C. Une excision du naevus pour un examen histologique
- D. Proposer une interruption de grossesse
- E. Revoir la patiente dans 3 mois

Rhumato.
57. Patiente âgée qui a depuis deux jours de violentes douleurs à la marche dans le dos et dans les jambes, ne parvient plus à marcher plus de 200m. **Pas de trauma**. A la consultation, **douleur à la palpation lombaire** et paralombaire ainsi qu'à la **percussion de T8**, muscles paravertébraux très contractés, pas de déficit neuro ou musculaire, Lasègue négatif.

Quel est l'examen à faire?

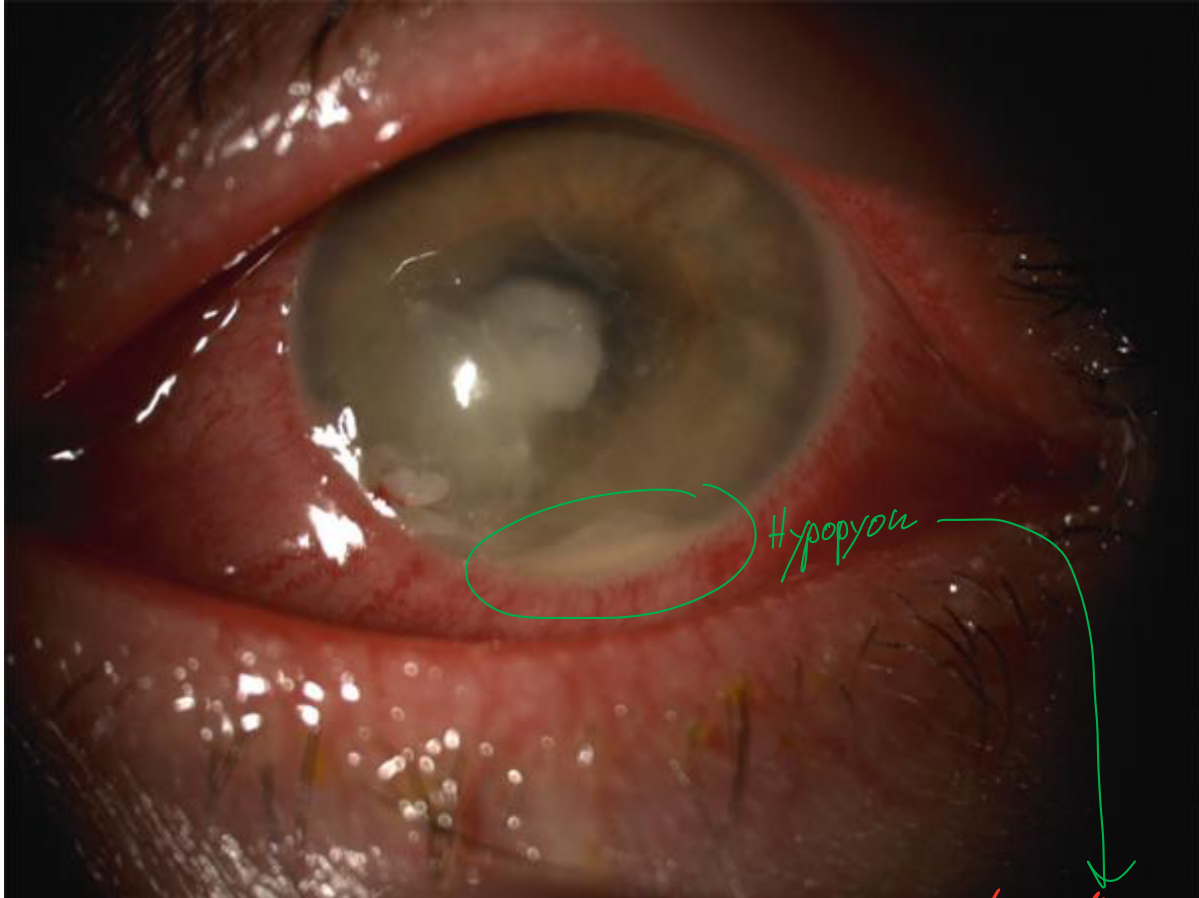
- A. Densité osseuse
- B. IRM
- C. Radiographies lombaires
- D. CT de la colonne

Fracture du corps vertébral

E. US doppler des MI

Ophthalmo. 59. Une patiente de 35 ans en bonne santé habituelle consulte en urgence pour des douleurs aiguës à l'oeil depuis la veille. Porteuse de lentilles, elle n'en a pas remis depuis la veille.

↳ Kératite à Acanthamoeba ou Pseudomonas!



↳ Kératocconjunctivite bactérienne

Quel est la prise en charge à initier?

- A. Mesure du pH
- B. AINS et corticostéroïdes topiques
- ☒ C. Prélèvement et antibiotiques topiques
- D. Antibiotiques systémiques et prélèvement
- E. Couverture avec patch oculaire et crème locale

Rhumato. 61. Un homme d'environ 60 ans en BSH se présente pour des douleurs au niveau du genou droit depuis quelques semaines. L'anamnèse ne révèle pas de traumatisme, ni élément déclencheur. Le status met en évidence un genou sans signe inflammatoire hormis un léger épanchement. De plus, vous constatez une légère déformation en varus du membre inférieur droit.

Quel imagerie initiale semble la plus appropriée?

Suspicion arthrose?

- A. Un CT scan du genou droit

- B. Un arthro- CT du genou droit
- ☒ C. Des clichés de radiographies standards du genou droit
- D. Une IRM du genou droit
- E. Une échographie du genou droit

HTA
→ 62. Une femme de 72 ans connue pour une HTA traitée et un diabète consulte pour un oedème de la lèvre supérieure qui est apparue sur la nuit. Le traitement habituel est de metformine, un IECA et un diurétique. Le soir elle a mangé une salade, du poulet, des frites et un yaourt au chocolat. Quelle mesure faut-il prendre?

- A. Remplacer le diurétique
- B. Arrêter la metformine
- ☒ C. Remplacer l'IECA par un antagoniste du récepteur à l'angiotensine (ARA)
- D. Organiser une consultation allergologique pour effectuer des prick test cutanés
- E. Tester les allergies médicamenteuses

Neuro.
TVP 63. Une femme de 36 ans, sous contraception orale, obèse, se présente aux urgences d'un hôpital périphérique. Elle présente depuis 15 jours des céphalées holocrâniennes inhabituelles non soulagée par Irfen/Dafalgan. TA 150/80, 90 bpm, examen neurologique sans latéralisation ni signe méningé. Fond d'oeil : Papilles avec bords flous. Quelle prise en charge ?

- A. Traitement par Triptans
- ☒ B. Neuroimagerie en urgence
- C. Transfert en neurochirurgie au CHU le plus proche
- D. Traitement par Acétazolamide et rdv de contrôle chez le neurologue
- E. Corticoïdes et transfert en neurologie au CHU voisin

Neuro. 64. Homme de 28 ans, consulte pour raideur des jambes depuis 1 semaine, associés à des paresthésies type picotement, plus à droite qu'à gauche. Au status il y a une hyposensitivité en dessous de D10, hyperréflexie et paralysie spastique des jambes. Il a quoi?

- ☒ A. Lésion médullaire
- B. Lésion cérébrale
- C. Neuropathie périphérique
- D. Trouble de l'irrigation vasculaire
- E. Problème osseux

Neuro.
TVP 73. Un homme de 60 ans, en bonne santé habituelle et sans traitement vous appelle au cabinet pour une douleur dans le mollet droit avec un gonflement associé. Il part prochainement en vacances pour 3 semaines à "loindetout-sur-mer" et aimerait savoir s'il peut se traiter avec du paracétamol.

Que faites vous?

- A. Vous lui donnez une ordonnance pour paracétamol 3g/j pendant 3 semaines.
- B. Organisez un US en ambulatoire
- ☒ C. Demandez de venir au cabinet pour faire un bilan diagnostique
- D. Appelez une ambulance pour hospitalisation en urgence
- E. Vous lui demandez de rappeler dans 2 jours pour voir l'évolution

Cardio.
FA

74. Une femme de 61 ans connue pour une coronaropathie et une FA, présente une fréquence cardiaque à 110 bpm avec malaise (ou vertige?). Elle est sous traitement de métoprolol, coumarine (AVK), métoprolol, candésartan, ?? La coronarographie ne montre pas de progression de la coronaropathie. On pense que la symptomatologie est due à un traitement inadéquat de sa FA. Sa créat est à 200. Que faire?

- A. Ajout Clonidine
- B. Augmenter la dose de métoprolol
- C. Augmenter la dose de andésartan
- D. Ajout digoxine**
- E. Augmenter la dose de diurétique

Etudes
cliniques

Xx. De nos jours, le rapport entre l'exposition à l'amiante et le mésothéliome a été prouvé. Si ce n'était pas le cas, quel type d'étude serait le plus approprié pour prouver ce lien?

- A. Etude cas-témoin = rétrospective**
- B. Etude transversale
- C. Etude de cohorte = prospective
- D. Etude randomisée contrôlée

Stat.

Xx. Un jeune étudiant en médecine a des douleurs en FID, de la fièvre, bref il a une appendicite. Il est conduit en voiture aux urgences et à chaque dos d'âne (gendarme couché) il est pris de violentes douleurs. Aux urgences il tape la discute avec un médecin assistant qui se souvient avoir lu une étude qui disait que sur 60 patients amenés aux urgences en ambulance qui se plaignaient de douleurs aux passages des dos d'ânes 30 avaient une appendicite et 30 un autre diag.

La sensibilité de ce test est de 97% et la spécificité de 30%. Quelle est la probabilité selon cette étude que notre bonhomme ait une app ? $VPP = \frac{VP}{VP+FP} = \frac{30}{30+30} = 50\%$

- A. 0 à 19%
- B. 20 à 39%
- C. 40 à 59%**
- D. 60 à 89%
- E. 90 à 100%

		Maladie		
		Malade	Sain	
Test	⊕	VP	FP	$VPP = \frac{VP}{VP+FP}$
	⊖	FN	VA	$VNP = \frac{VN}{VN+FN}$
		Sens $\frac{VP}{VP+FN}$	Spec $\frac{VN}{VN+FP}$	

Dermato.

83: Une patiente de 73 ans se présente avec un **ulcère au niveau de la malléole interne** à droite. Vous constatez une **corona phlebectica** et des **tâches brunâtres** au niveau des deux membres inférieurs.

Quelle affection est le plus probablement à l'origine de ces lésions?

- A) Artérite oblitérante des membres inférieurs
- B) Eczéma toxique
- C) Érysipèle
- D) Thrombose veineuse profonde
- E) Insuffisance veineuse**

Légale

89. Patient de 54 ans, retrouvée décédée dans son appartement. Les voisins racontent que la patiente a été chez son médecin traitant le jour d'avant pour une dyspnée. L'examen clinique ne révélait rien de particuliers. Les D-Dimères étaient dans la norme.

Que faire?

- A. Autopsie clinique
- ☒ B. Autopsie médico-légale
- C. Autopsie vasculaire
- D. Angio-CT post-mortem
- E. CT post mortem

Néphro.

90. Femme dans un EMS n'arrive plus à faire pipi et trouble de l'état de conscience. Elle a vomit plusieurs fois les jours d'avant.

Qu'est ce qui explique le mieux son état ?

- ☒ A. Déshydratation et Hypokaliémie
- B. Déshydratation et Hyperchlorémie
- C. Déshydratation et Hyperphosphatémie
- D. Hypoglycémie et Hyperkaliémie
- E. Insuffisance rénale post-rénale

↓
Alcalose métabolique

Infectio.

106. Une femme enceinte est amenée en ambulance. Elle présente de la fièvre et des céphalées depuis la 2 jours. Ce matin elle a perdu connaissance avec un épisode de convulsion. Au urgences vous retrouvez une femme avec un GCS à 13, de la fièvre à 39.3°C. Vous effectuez une PL qui revient claire avec une majorité de lymphocyte. À la coloration de ziehl, vous ne retrouvez pas de bactérie. Quel est le micro-organisme le plus probable :

- streptocoques pneumoniae
- Entérocoques Faecalis
- ☒ - listeria monocytogenes (Grossesse = FR pour la Listériose)
- Neisseria Méningocoque
- haemophilus influenzae b

Oncol.

110. Un homme sous chimiothérapie à visée curative pour un cancer du colon. Il y a quelques mois on lui découvre des métastases hépatiques et pulmonaires. Le traitement de chimiothérapie est maintenant à visée palliative. Il se présente à la consultation avec une lésion cutanée sur l'avant-bras (photo: je sais pas ce que c'était mais c'était légèrement surélevé, rose, rond):

- Dermatofibrosarcome de Darier-Ferrand
- Mycose cutanée
- Métastase cutanée
- ☒ - Lésion toxique cutanée liée à la chimiothérapie
- Chéloïde

Légale

X. Dans la forêt on trouve un **cadavre en position ventrale**. Quel est le signe le plus clair qui montre que la personne est morte ?

- A. Rigidité des 4 extrémités
- B. Tâches rouges violacées qui ne partent pas à la pression **au niveau du dos** = *lividités cadavériques*
- C. Une température auriculaire $< 25^{\circ}\text{C}$
- D. Pas de pouls ni de resp
- E. Anisocorie

Agitation
OH/noques

123. Un homme de 24 ans est amené aux urgences par la police. Celle-ci l'a arrêté car il voulait frapper partout avec une bouteille de bière et qu'il était agité. Aux urgences il est désorienté sur le plan spatio-temporel. Il se plaint de fortes douleurs au thorax et à la tête. Il est fébrile (38.5). Sa TA est $210/120$, sa FC $120/\text{min}$, régulière. Il est difficile de l'examiner puisqu'il remue les jambes et les bras. Il ferme ses yeux/paupières quand on veut évaluer ses pupilles.

Que faut-il lui administrer en premier en i.v. ?

- A) Esosmol
- B) Glucose
- C) Haloperidol
- D) Lorazepam = *Temersta* (Bzol)
- E) Morphine

Péd.

X. Un garçon de **5 ans** est amené aux urgences par son père. Il a présenté après sa douche, une vive **douleur du pénis**. Cf. image



Quel est le Dx le plus probable ?

- A. Balanite aiguë
- B. Paraphimosis**
- C. Lichen
- D. Eczéma du gland
- E. Prépuce en tablier de sapeur

Péd. Dermat.

X. Une fillette présente un **érythème fessier**. Elle a une **gastroentérite** la semaine passée. L'**oxyde de Zinc** appliqué par la maman n'a pas permis d'améliorer l'érythème. Quelle est la cause la plus probable ?

- A. Candida**
- B. Herpès
- C. S. aureus
- D. Carence en folates

*↳ a créé une dermatite irritative
Candidose des langes (sur dermatite irritative)*

Neuro.

98. Une dame de 33 ans en bonne santé habituelle vient aux urgences pour une **diminution de la vision** depuis quelque temps. Elle présente également des **céphalées** et une **aménorrhée secondaire**. Elle ne se plaint pas de fièvre ni de méningisme. Dans la précipitation, vous réalisez un IRM cérébral qui donne le cliché d'ultra haute définition suivant. (Evidemment que dans le stress, la grande boule de billard au milieu du cerveau ressemblait à une boulinette).



Vous concluez à:

- A) Une hypertension intra-crânienne.
- B) Une métastase cérébrale
- ☒ C) Un macroadénome hypophysaire
- D) Une Tuberculose (même s'elle est pas érythréenne, ça arrive).

*Neuro-
AIT*

Xx. Un patient de 70 ans vous téléphone le matin à votre cabinet de généraliste en raison d'une **faiblesse** survenue au bras droit le matin-même vers 8:00. L'épisode a **duré environ 30min** et s'est **résolu spontanément**. Il n'y a pas eu d'autre altération et il ne conserve aucun déficit.

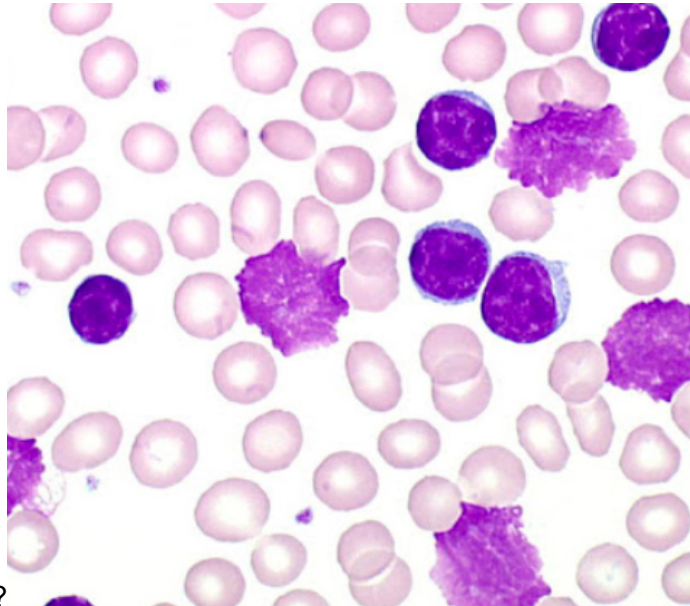
Quelle est l'attitude la plus indiquée?

- A) Rassurer le patient
- B) Organiser une IRM de contrôle d'ici une semaine
- ☒ C) Envoyer immédiatement le patient dans un stroke center
- D) Organiser une consultation dans la journée dans votre cabinet
- E) Contrôle chez le neurologue le lendemain

Hémo-onco-

115. Femme de 69 ans qui se présente chez son médecin traitant pour une **asthénie**. Au status vous trouvez des **adénopathies généralisées**, et une **hépatosplénomégalie**. Hb 100 g/L, Tc 210

g/L, Leucocytes 37 G/L. *>10 = leucocytose*
Au frottis:



Quel est le diagnostic ?

Ombres de Guenepied

- A. Leucémie myéloïde chronique
- B. Leucémie lymphoïde chronique**
- C. Lymphome lymphoplasmocytaire (pas sûre de cette proposition)
- D. Lymphome de Hodgkin (pas sûre de cette proposition)

Neuro. 70. Un homme de 70 ans est amené aux urgences par sa femme qui est inquiète en raison d'un épisode de **perte de conscience** le soir, alors qu'il était au lit. L'épisode n'a duré que **2-3 min** maximum et dès la fin le patient a immédiatement reconnu sa femme. Il n'y a pas de morsure de langue et il n'y a pas eu de perte d'urine. Lors de l'épisode il y a eu des **clonus** des membres supérieurs, **sans prodromes**. Aux urgences le patient n'a pas de signes neurologique mais il est connu **cardiopathie avec une FEVG à 25%**. Quel est l'étiologie la plus probable de cet épisode de syncope?

- A. Epilepsie
- B. Cardiaque**
- C. Psychogène
- D. Vaso-vagal
- E. Métabolique

Ortho.

Xx. Une femme de 87 ans, glisse de sa hauteur et se réceptionne sur sa hanche. Aux urgences la radiographie du bassin montre une **fracture déplacée du col fémoral droit**. Que peut-on retrouver à l'examen clinique:

- A. un allongement du membre inférieur droit en rotation interne
- B. un raccourcissement du membre inférieur droit en rotation interne
- C. un allongement du membre inférieur droit en rotation externe
- D. un raccourcissement du membre inférieur droit en rotation externe**

Ortho.

Xx. Enfant avec **fracture** franche du radius. La mère vous demande des informations sur la guérison. Qu'est-ce qui est juste :

- A. inflammation - granulation - cal - remodelage**
- B. granulation - cal - inflammation - remodelage
- C. granulation - inflammation - remodelage - cal
- D. Inflammation - cal - granulation - remodelage

Xx. 5 jours après une **résection gastrique**, un patient de 67 ans sans problème cardiaque se plaint de **dyspnée**. Sa température est de **38.5 °C**. La radiographie du thorax montre un **diaphragme élevé**, un **effacement du cul-de-sac diaphragmatique** et un **pneumo-bronchogramme**.

Quel est le diagnostic le plus probable?

- A. une pneumonie postopératoire**
- B. une atélectasie de compression
- C. un abcès sous phrénique
- D. un oedème pulmonaire aigu typique
- E. une rupture de la rate

épaulement pleural

Ophthalmo.

Xx. Un patient de 23 ans vient à votre consultation car depuis plusieurs jours il a **mal à sa paupière inférieure gauche**. **Pustule à 2mm des cils** au. Acuité visuelle normale. Lorsqu'on essaie de toucher la paupière inférieure le patient se recule et se plaint de **douleur**. Quel est le dg le plus probable?

- A. Orgelet**
- B. Chalazion
- C. Dacryocystite
- D. Dacryoadénite

Xx. Garçon de deux ans vient consulter avant une chirurgie prévue pour une absence de testicule dans le scrotum. Au contrôle des 1an, les deux testicules étaient dans le scrotum. Puis lors d'une prochaine consultation, le testicule droit n'était plus palpable. Aujourd'hui, le testicule est palpable mais remonte dans le canal inguinal au moindre geste. Que faire ?

- A. Continuer le traitement
- B. Recontrôler dans 2 ans
- C. Organiser une chirurgie en urgence
- D. Annuler la chirurgie

Xx. J'ai oublié le tableau clinique lol, mais il fallait analyser un séro HBV: HBs antigène nég, anti-HBs + avec un taux anti-HBs élevé (il y a la valeur normale donnée), anti-HBc IgM/IgG +

- A. infection HBV aigue
- B. Infection HBV chronique active
- C. couverture vaccinale HBV suffisante
- D couverture vaccinale HBV insuffisante
- E. infection HBV chronique inactive
- F. Infection HBV guérie

Xx. Un patient vous consulte pour une faiblesse progressive des deux jambes depuis quelques jours. Il y a 3 semaines, il a souffert d'une diarrhée fébrile. A l'examen, on trouve une force et un tonus musculaire diminués, mais une sensibilité cutanée conservée. Les réflexes musculaires sont absents. Les nerfs crâniens et les membres supérieurs sont sans particularité. Quel examen confirmera le diagnostic qu'il-faut suspecter?

- A. une ponction lombaire
- B. une IRM de la colonne lombaire
- C. une électromyographie
- D. un dosage de la glycémie
- E. un dosage de la vitamine B12 sérique

Xx. En vous baladant dans Lausanne vous tombez sur un amasement de gens autour d'un jeune d'une 20aine d'années qui est inconscient et non réveillable. Vous noté qu'il a un myosis et une bradypnée. Quel est la substance la plus probablement en cause ?

- A. Ampéhtamines
- B. Héroïne
- C. Cocaïne
- D. OH

Xx. Femme enceinte à 39SA avec suspicion de pré-éclampsie, dont on va induire l'accouchement. Quelle est l'anesthésie qu'on va utiliser pour traiter les douleurs de l'accouchement et l'hypertension?

- A. Sous-durale
- ☒ B. Dans l'espace épidural
- C. Sous la dure mère
- D. Dans l'espace sous-arachnoïdien
- E. Dans le liquide céphalo-rachidien

Xx. Une patiente vous contacte car elle aimerait rédiger ses directives anticipées. Qu'est-ce qui est vrai par rapport aux DA :

- A. Doit contenir son positionnement sur la réanimation ou la non-réanimation lors d'hospitalisation
- B. Peuvent être rédigées sur une feuille vierge sans formulaire
- C. Priment en cas d'hospitalisation même si patient est capable de discernement

Xx. Tableau avec cluster headache (injection conjonctivale, etc.)

Quel ttt administrer en premier :

- A. AINS
- B. morphine
- C. O2
- D. Triptans

Xx. Homme qui se présente aux urgences pour paresthésie faciale unilat du territoire V1-V2, qui sont accompagnée de douleurs +++ dans le même territoire (jusqu'à 4x par jour pdt 40min je crois), absence de réflexe cornéen du même côté. Quel est le diagnostic?

- A. Névralgie d'Arnold (nerf grand occipital (?))
- B. Névralgie trigéminal
- C. Algie vasculaire de la face
- D. Migraine avec aura sensitive

Xx. Patient avec virage maniaque sous AD. Qu'est-ce qu'on doit faire.

- A. Stopper le ttt AD
- B. Stopper l'AD et le remplacer par un stabilisateur de l'humeur
- C. Ajouter un stabilisateur de l'humeur à l'AD
- D. Laisser l'AD
- E. Changer d'AD

Xx. Tableau clinique d'un jeune ayant subi une extraction dentaire (dent 38) avec ensuite complication par un méga abcès (image CT). Qu'est-ce qui incite à une chirurgie en urgence ?

- A. Trismus

- B. Dysphagie
- C. Foetor
- D. Douleur à l'ouverture de la bouche

Xx. Tableau d'épisode dépressif. Qu'est-ce qu'il faut faire pour exclure une atteinte somatique ?

- A. Dosage de la TSH
- B. Echocardiographie

Xx. Enfant avec Tableau de pneumonie avec tuberculose

- A. Métronidazole
- B. Isoniazide, éthambutol, pyrazinamide, rifampicine
- C. Co-amoxicilline
- D. Isoniazide

81. Homme de 80 ans avec un cancer multimétastatique, se présente pour un tableau d'hémorragie et de multiples embolies pulmonaires. Le TP, l'aPTT et les plaquettes sont effondrés. Quel examen de laboratoire allez-vous demander pour confirmer le diagnostic suspecté:

- A. Dosage du fibrinogène
- B. Multimère de du facteur von Willebrand
- C. Taux de facteur VIII et facteur IX
- D. Taux du facteur V
- E. Dépistage du TIH

Xx. Jeune femme de 19 ans sous pilule depuis 2 mois, se présente chez son médecin pour des saignements intermenstruels. Auparavant jamais eu de méno/métrorragie. Pas d'autres Symptômes, test de grossesses négatif. Que faire?

- A. Biopsie de l'endomètre
- ☒ B. US endovaginal
- C. Rassurer la patiente et continuer la pilule
- D. ?
- E. ?

Xx. Patient de xx ans qui se plaint de prurit et de symptômes B (?). Labo montre érythrocytose isolée. EPO diminuée. Comment poser le Dx

- a. JAK2
- b. Oxymétrie nocturne
- c. ?

Xx. Méga long tableau clinique de lymphome avec cellules de Reed-Sternberg (c'est dit dans l'énoncé, pas d'image), quel est le diagnostique ?

- A. Lymphome de Hodgkin
- B. Lymphome folliculaire
- C. Lymphomes à grandes cellules
- D. Lymphome MALT

Xx. Femme qui vient aux urgences pour ictère après avoir bien bu bien mangé la veille, ils donnent un labo qui montre des tests hépatiques perturbés (ASAT 180, ALAT 150, bili et GGT) et amylase à la limite sup de la norme (60), et faut poser le Dx:

- A. Migration biliaire
- B. Hépatite OH
- C. Hépatite virale
- D. Adénocarcinome du pancréas
- E. Pancréatite OH

Xx. Femme de 34 ans garde forestière très inquiète qui vous consulte au mois de février en raison de fatigue, céphalées, fièvre à 39°, douleurs musculaires. A eu un rapport sexuel non protégé il y a 3 mois. A peur d'avoir une méningite car une de ses amies en a eu une récemment. Quelle est la cause la plus probable ?

- A. Primo infection VIH
- B. FSME
- C. Influenza
- D. Méningite
- E. Trouble de conversion de type pseudo fievrum

Rhumato
Xx. Patient de x ans qui vient aux urgences pour une douleurs +++ au pied => tableau clinique typique de **gouttes** avec antécédants de 3 crises dans le passé (non dx donc non-tx) et insuffisance rénale, quel traitement?

- A. Allopurinol *Pas pdt la crise*
- B. AINS *contre-indiqué car IRC*
- C. Prednisone
- D. Methotrexate
- E. Cyclophosphamide

La colchicine n'était pas dans les propositions de réponse

Xx. PATient avec polypharmacie, est sous traitement ATB de clarithromycine depuis quelques jours pour une pneumonie. ES = vision verte, nausées et vomissements, quel est le traitement impliqué?

- A. Digoxine
- B. Clarithromycine

- C. Candésartan
- D. Furosémide

Xx. Patient avec hypoesthésies des bouts de l'index et du majeur. Quel nerf touché ?

- A. N. médian
- B. N. radial superficiel
- C. N. ulnaire
- D. N. axillaire
- E. N. fémoral

Xx. Jeune homme de 25 ans qui fait un BBQ: le BBQ explose et il est brûlé au visage. Les ambulanciers viennent le chercher et l'hydratent, patient stable pendant le transport vers l'hôpital cantonal, mais voix commencent à se modifier (c'est pas formulé exactement comme ça, je sais plus si l'énoncé décrivait dysphonie vs dysphagie vs "fermeture des VA"). Que faut-il faire immédiatement:

- A. Antibiotique
- B. Maintenir les voies aériennes perméables
- C. Perf NaCl?
- D. ?

Xx. Homme de x ans qui travaille dans une entreprise avec produits x, qui a un carcinome urothélial. Quel produit professionnel peut être la cause de ce cancer

- A. Huile minérale
- B. βnaphtylamine
- C. Amiante
- D. Essence
- E. ???

Xx. Un homme de 25 ans est amené dans votre cabinet avec une morsure de serpent à la jambe droite. Il s'est fait mordre il y environ 2 heures durant une randonnée dans les Alpes. Selon sa description, le serpent était vraisemblablement une vipère. Il ne présente pas d'antécédents médicaux particuliers et ne connaît pas son statut vaccinal. Les paramètres vitaux sont stables. L'examen physique montre un oedème légèrement rouge au niveau de la morsure. A part la douleur locale, le patient ne se plaint de rien, mais il est très inquiet. Parmi les mesures suivantes, laquelle est la plus indiquée?

- A. Ligature de la jambe au dessus du niveau de la morsure
- B. Rappel antitétanique IM
- C. Antitoxine IV
- D. Débridement de la zone de morsure
- E. Fasciotomie de la jambe en urgence

Xx. cas d'un homme qui fait plusieurs examens pour un ictère => adénocarcinome pancréatique. Il vient à votre cabinet pour les résultats et vous demande : "Dr, dites moi où en suis-je exactement". Quelle est la réponse la + appropriée?

÷ fu stade du cancer

- A. Le gastro-entérologie va vous poser un stent
- B. Il faut qu'on vous opère
- C. Vous avez une maladie incurable
- D. Vous avez une espérance de vie de 2-3 ans
- E. Il faut faire une chimiothérapie

Xx. Un garçon de 12 ans s'est écrasé la tête la première il y a 2 jours à un match de hockey. Ses coéquipiers disent qu'il a perdu connaissance pendant environ 15 minutes. Il a été par la suite confus pendant 30aine de minutes. Depuis lors sa mère rapport qu'il des maux de tête et des difficultés pour se concentrer sur ses devoirs. La mère vous demande s'il peut à nouveau participer à ses matches de hockey. Status cliniques sp, quand il saut sur une jambe dans le cadre de l'examen neuro, il signale avoir mal à la tête. Que faire:

- A. Hospitalisation pour observation
- B. CT cérébral
- C. Le patient décide si il joue un match ou non
- D. Les patients doivent surveiller l'enfant toutes les 4h pendant 48h
- E. Interdiction de faire du sport jusqu'à résolution complète des symptômes.

Xx. Un homme de 80 ans, ancien enseignant et fumeur à la chaîne, vient vous consulter à votre cabinet. Il a subi une résection transurétrale de la prostate (TURP) il y a 10ans. Le patient est traité depuis 20ans pour une hypertension artérielle. Il présente une insuffisance cardiaque grave depuis plus de 3 mois. Il vous demande s'il doit faire un test de dépistage du cancer de la prostate. Il n'a pas d'antécédents familiaux de carcinome de la prostate. Vous lui déconseillez de faire un dépistage. Quelle est la principale raison de cette décision ?

- A. Faible valeur prédictive du dosage préventif des PSA
- B. Biais du dosage des PSA par les antihypertenseurs
- C. Biais du dosage des PSA par la TURP
- D. Absence d'antécédents familiaux
- E. Faible espérance de vie résiduelle du patient

Xx. Patient prenait de l'amiodarone, arrêtée depuis plusieurs mois. T4 mesurée à 50, anticorps anti récepteurs de la thyroïde négatifs. C'est probablement:

- A. Une hyperthyroïdie causée par l'amiodarone

- B. Une hyperthyroïdie de type Basedow
- C. Une hypothyroïdie de type Hashimoto
- D. Une hyperthyroïdie xxx
- E. Une hypothyroïdie yyy

Gynéco. Xx. jeune femme avec frottis de col qui montre de nombreuses bactéries + CIN, que faire:

- a. Conisation
- b. Antibiothérapie
- c. Vaporisation laser
- ☒ d. Biopsie du col *Sex CIN 2*
- e.

Gynéco. Xx. Pourcentage de cancer du col associé à HPV

- A. 10-20%
- B. 20-40
- C. 40-60%
- ☒ D. 60-80%
- E. > 90

Xx. Un papi qui a hématochézies et autres trucs dont je ne me souviens pas... Et on demande quelle est la première chose à faire ?

- A. Gastroskopie
- B. Colonoscopie
- C. Ligature des hémorroïdes

37. Malgré un traitement diurétique, un patient de 47 ans connu pour une cirrhose hépatique se présente aux urgences avec une ascite massive accompagnée d'une dyspnée. Il présente de plus une hyponatrémie à 125 mmol/l et une hypoalbuminémie à 20 g/l. Quel est le meilleur traitement dans l'immédiat ?

- A. Donner de l'albumine
- B. Furosemide IV
- C. Spironolactone IV
- D. Paracentèse de plusieurs litres
- E. Corriger l'hyponatrémie avec une solution de NaCl hypertonique

Xx. Cancer avec métastases ttt par ...imab. Présente une sorte d'ulcère cutanée. (image qui ressemblait un peu à ça)



De quoi s'agit-il ?

- A. Métastase cutanée
- B. vasculite cutanée
- C. EIS de la chimio

Un homme de 93 ans, dément, est hospitalisé pour une prothèse de hanche totale. Suite à des complications infectieuses, l'homme est immobilisé au lit pendant deux semaines. Une incontinence fécale et urinaire vient encore compliquer le travail des soignants. Au bout de 5 jours, apparition d'une rougeur violacée au niveau du sacrum. Selon vous, quelle mesure aurait pu prévenir ça ?

- A. Crème hydratante plusieurs fois par jour
- B. Changement régulier de position
- C. Compresse d'eau froide et séchage
- D. Hyalugel et chirurgien plastique très cliché
- E. Une pizza fratel pastore

Ophthalmo.
Xx. Femme âgée qui a été opérée pour la **cataracte** aux deux yeux il y a plusieurs années qui se présente pour vision floue de l'œil D. et éblouissement.
Quelle est la cause ?

- ☒ A. Opacification de la capsule postérieure = *cataracte secondaire (complication de la chir. de la cataracte)*
- B. Glaucome
- C. ?
- D. ?

122. Femme BPCO stade IV qui a été hospitalisée récemment pour insuffisance respiratoire. Elle se rend à votre cabinet de généraliste pour faire faire des directives anticipées. Comment pouvez-vous mieux la renseigner ?

- A. Les directives anticipées doivent absolument contenir des informations concernant la réanimation et non réanimation.
- B. Les directives anticipées prévalent sur la parole en cas de perte de capacité de discernement.
- C. La fille doit donner son accord (?).

D. Les directives anticipées peuvent se faire sur un papier, ne doivent pas obligatoirement être faites sur un formulaire

Réponse D

36. Un jeune garçon a eu un TC lors du sport il y a eu deux symptômes, suivi d'une perte de connaissance de moins de 15 minutes selon les camarades mais le prof de sport n'en est pas sûr. Depuis, sa maman le trouve moins actif. Il se plaint de céphalées et de troubles de la concentration. Il fait refait un match du rugby et a eu des céphalées. L'examen neurologique clinique est normal, hormis le test du sautillement sur un pied qui reproduit les céphalées. Quel prise en charge est la plus adéquate ?

A. Faire une imagerie cérébrale.

B. Dire au parents de surveiller toutes les 4h pendant 48h.

C. Hospitalier pour surveillance.

D. Arrêter le sport jusqu'à résolution des symptômes.

47. Un enfant de 18 mois présente des épisodes douloureux aigus avec pleurs, pâleur et sang dans les selles. À l'anamnèse, la mère signale un épisode fébrile avec une rhinite la semaine précédente. Parmi les diagnostics suivants, lequel faut-il en premier confirmer ou infirmer?

- (A) maladie de Hirschsprung
- ☒ (B) invagination
- (C) volvulus gastrique
- (D) diverticule de Meckel
- (E) reflux gastro-œsophagien

110. Un homme de 35 ans est hospitalisé en psychiatrie à cause d'un délire de grandeur et d'hallucinations auditives lui disant qu'il doit sauver le monde. On apprend par ses proches qu'il a consommé des quantités croissantes d'alcool au cours des dernières semaines. Après avoir reçu une injection d'halopéridol intramusculaire, la situation s'améliore progressivement. Quelques heures plus tard, le patient montre à nouveau des troubles du comportement, ne veut pas rester tranquille plus d'une minute lors de l'entretien avec l'infirmière. Au cours de la nuit, il exige sa sortie tout en se plaignant de douleurs musculaires. Il semble très tendu, et montre par moments des postures étranges. Une heure plus tard, son discours devient difficilement intelligible, tant il prononce mal les mots. Quelle est la cause la plus probable de cet état?
- (A) une anxiété dans le cadre d'un état psychotique
 - ☒ (B) un effet secondaire de l'halopéridol
 - (C) une lésion cérébrale
 - (D) un sevrage d'alcool
 - (E) une simulation

Xx. Un patient âgé d'environ 70 ans est diagnostiqué avec un cancer urothélial. Par le passé, vous apprenez qu'il a travaillé avec de nombreux composés chimiques. Lequel peut favoriser le développement d'un cancer urothélial?

- A. L'amiante
- B. L'essence
- C. Les huiles minérales
- D. Le β -naphthalène

Xx. Un patient de 82 ans ayant des antécédents de consommation chronique d'alcool est hospitalisé pour un delirium tremens. Au laboratoire, vous retrouvez une thrombocytopénie sans autre signe clinique ou biologique. Quelle est la cause la plus probable ?

- A. Splénomégalie
- B. Aplasie médullaire
- C. Carence en vitamine B12
- D. Carence en folates
- E. Hémorragie gastro-intestinale

Xx. Un jeune homme de 23 ans se présente dans une clinique universitaire pour une douleur de la nuque apparue 2h après un entraînement en vue d'un match de rugby. A l'examen clinique, on trouve une légère anisocorie, ainsi qu'un myosis et une ptose plus prononcés à gauche qu'à droite. Que faites-vous ?

- A. Scanner
- B. IRM et angio-IRM
- C. Consultation en neurologie le lendemain
- D. Ponction lombaire

E. Contrôle dans une semaine

Type K'

(K') Un agriculteur de 42 ans est amené aux urgences en raison d'une dyspnée qui est apparue après avoir rempli la remorque-citerne avec un produit phytosanitaire. Il se trouvait à ce moment dans un local fermé et le moteur de son tracteur tournait. Sa pression artérielle est de 100/60 mmHg, son pouls de 50/min. Ses pupilles sont d'un diamètre moyen. Une salivation importante est particulièrement frappante.

Quels traitements vont devoir lui être administrés ?

- A. la physostigmine
- B. L'atropine
- C. le naloxone
- D. le flumazénil

Gynéco. (K') Femme avec douleurs abdominales basses, écoulement purulent du col, utérus et col douloureux à la mobilisation, stix urinaire nég (je crois). Avec quoi cette pathologie peut-elle être associée

- ☒ A. péri hépatite
- ☒ B. Stérilité
- ☒ C. GEU
- ☒ D. Douleurs abdominales chroniques

(K') : CT avec fracture de l'arc zygomatique déplacée. Quelles sont les indications pour opérer?

- A. Risque de pseudarthrose
- B. Va faire une déformation inesthétique
- C. Va avoir des difficultés pour ouvrir la bouche si pas réparé
- D. Instabilité de l'arc moyen du visage

Dermato. K'

Deux frères et soeurs se grattent derrière les oreilles et le cuir chevelu. Ils présentent des lésions de grattage et des enduits blanchâtres autour des follicules pileux.

- A. Un traitement antifongique per os est indiqué *non, topique*
- ☒ B. Ils peuvent aller à l'école avant l'initiation du traitement
- ☒ C. L'atteinte peut aussi être au niveau des cils et sourcils.
- ☒ D. Peut se sur infecter par Pseudomonas

Dermatite seborrhéique?
6 - + + +
Poux?
- + - +

1. Vous êtes de garde en tant que médecin assistant.e. Une femme de 22 ans se présente aux urgences suite à une fête en boîte de nuit. Elle a consommé une substance blanche. Elle a sniffé cette substance par le nez en pensant qu'il s'agissait de cocaïne, mais elle est maintenant très inquiète qu'il s'agisse en fait d'une autre substance.

Quel signe est le plus évocateur d'une intoxication à la cocaïne ?

- A) bradycardie
- B) envie de dormir
- C) mydriase
- D) diminution de la transpiration
- E) parle peu

11. Femme de 80 ans, HTA et diabète de type 2, sous metformine et lisinopril, a des diarrhées aqueuses et douleurs au ventre. Son petit fils, très futé, lui donne des AINS. Comme elle a toujours mal après quelques jours, elle continue d'en prendre. Par la suite, elle présente des douleurs abdominales et une respiration accélérée. Comment expliquer ses symptômes ?

- A. Acidose lactique
- B. Insuffisance rénale aigue
- C. Déshydratation
- D. Obi-Wan Kenobi
- E. Colite pseudomembraneuse

Neuro - 21. Une jeune femme qui a des signes et symptômes qui font évoquer une **névrite optique** (le diagnostic est donné dans l'énoncé). La question: quel est l'examen qui permet de poser le diagnostic de **sclérose de plaques** à ce moment ?

- A) IRM
- B) EEG
- C) Un frottis nasopharyngé avec PCR SARS-CoV-2
- D) Anticorps anti-MOB
- E) Mesure de la vitesse de conduction par EMG des grands nerfs

24. Homme de 55 ans, infarctus du myocarde sur thrombose de l'artère circonflexe il y a 6 mois, présente actuellement une akinésie de la paroi antéro-latérale à l'US.

Quelle complication craindre à long terme ?

- A. Fibrillation ventriculaire
- B. Tamponnade
- C. Péricardite
- D. Thrombo-embolisme
- E. Rupture de paroi

32. Vous voyez une patiente de 45 ans pour une grosseur d'apparition récente sous l'aisselle droite. Elle travaille et habite dans une ferme et a des contacts réguliers avec des chiens, des chats et des moutons. Il y a quelques jours, elle s'est blessée à la main droite. Actuellement la

plaie est cicatrisée. Au status, vous notez une petite cicatrice propre sur la main droite et une adénopathie axillaire droite douloureuse à la palpation. Pas d'autres adénopathies, pas de symptômes systémiques récents ni actuels. Quel est votre diagnostic?

- A. Bartonellose
- B. Brucellose
- C. Tuberculose
- D. Toxoplasmose
- E. Maladie des griffes du chat

41. Une patiente de 45 ans vient chez le généraliste pour un bilan de contrôle. Elle présente des épisodes de **dyspnées nocturnes deux fois par semaine** ainsi que **lors des activités physiques**. Durant ces épisodes elle décrit également une **respiration sifflante**. Elle prends occasionnellement un bêta-agoniste inhalé de courte durée d'action qui permet de soulager rapidement ses symptômes. La spirométrie montre une VEMS1 à 85% du prédit.

Qu'est-ce que vous faites ?

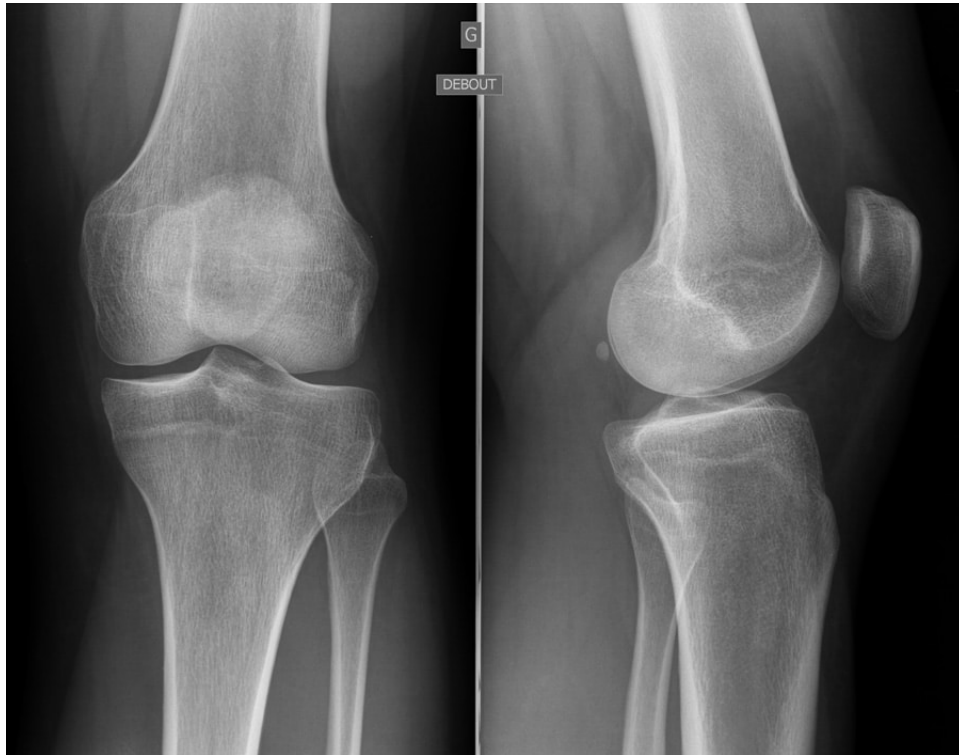
- A. Vous lui conseillez d'arrêter le sport
- B. Vous prescrivez un corticoïde pendant 7 jours
- C. Vous prescrivez un anti-leukotriène
- D. Vous prescrivez un bêta-agoniste de longue durée d'action, à prendre régulièrement
- E. Vous lui prescrivez un corticoïde inhalé et un bêta-agoniste de longue durée d'action**

51. Une femme de 58ans, sans antécédents, consulte son médecin de famille. Elle est inquiète car son cousin a récemment été diagnostiqué avec un diabète de type 1. Vous faites une HbA1g qui revient à 8.6% et une glycémie post-prandial à 13mmol/l. Quel traitement introduisez-vous?

- A. Biguanide (metformine)
- B. Sulfonylure
- C. Incretine
- D. Insuline

53. Un homme de 72 ans, sans antécédents particuliers, consulte pour une douleur du genou droit apparue il y a deux jours, sans traumatisme. La douleur est à la fois nocturne et diurne avec une impotence fonctionnelle et une réduction de la motilité. L'examen clinique montre une diminution de l'amplitude articulaire active et passive et un genou rouge, tuméfié et douloureux à la palpation. Les paramètres vitaux sont dans la norme, hormis une température à 38,0°C. Le labo montre une leucocytose à 13 G/L avec 8% de neutrophiles et une CRP élevée. La radiographie est la suivante :

Pneumo.
Asthme



La ponction articulaire effectuée met en évidence les points suivants :

- Liquide ponctionné jaune épais
- Numération cellulaire à 80 000 avec 81% de neutrophiles
- Absence de cristaux
- Pas de bactéries au Gram
- Culture en attente

Quel est le diagnostic le plus probable ?

- A. Rupture du ligament croisé antérieur
- B. Rupture méniscale
- C. Gonarthrose
- D. Goute
- E. Arthrite septique

57. Homme de 30 ans, diarrhées depuis 3 semaines. Pas d'état fébrile ni d'ictère, il a une hématochézie et une douleur en fosse iliaque droite. Légère défense sans détente, bruits abdominaux normaux. Quel est le diagnostic le plus probable?

- A. Maladie de Whipple
- B. Cancer du pancréas
- C. Maladie de Crohn
- D. Appendicite
- E. Cholecystite

59. Un patient de 30 ans se présente avec un état fébrile, des frissons et une perte de 5 kg sur 2 mois. Il est revenu d'un voyage en Asie il y a 3 mois. On lui fait une échographie qui montre une lésion hépatique hypo-échogène de 5x5 cm. Quel est le diagnostic le plus probable?

- A. Kyste hydratique
- B. Infection à *Martiniella*
- C. Schistosomiasis pulmonaire
- D. Amibiase

70) Femme de 75 ans, connue pour un cancer pour un cancer pulmonaire avec métastases hépatiques et osseuses à plusieurs endroits, hospitalisée pour une pneumonie depuis 3 jours, d'évolution favorable. Elle présente ce jour un **oedème de son MID nouveau**, prenant toute la jambe, sans douleur ni autres plainte. Pas de fièvre.

Au status, les diamètres des 2 jambes ont une différence de 5 cm et **l'oedème prend le godet**. Pas de rougeur ni de chaleur.

- Leuco très légèrement augmenté
- Pas de CRP
- Albumine abaissée

Quel test faire pour diagnostiquer cette maladie ?

- A) **Us**
- B) Angio-ct des membres inférieurs
- C) Dosage des dimères
- D) Un truc rien à voir

75) Jeune 22 ans, fracture ouverte traité par ostéosynthèse et lambeau libre. 4 mois après il vient chez le généraliste a toujours des douleurs à la charge. Pas de signes d'infection.

- A) AINS
- B) US à la recherche de la collection
- C) Rx pour évaluer le cal

79. Patient 25 ans, carreleur, rupture du LCA genou G à ski. Cicatrice douloureuse post-plastie l'empêchant de se mettre à genou. Doit travailler assis et doit donc être réorienté professionnellement. Qui est responsable du reclassement?

- A. case-management de l'assurance accident
- B. Assurance chômage
- C. Assurance invalidité
- D. ORP (office régional de placement)
- E. Autre truc bizarre de la commune

65(?): Enfant de **8 mois**, développe un **strabisme convergent** de l'œil D en 2 jours. Attitude?

- A rassurer les parents

TVP?

Ophtalmo

B Chirurgie correctrice

☒ C Fond d'œil *pour exclure un rétinoblastome ?*

☒ D Occlusion de l'œil sain

E Enucléation

Xx. Patiente connue pour une HTA hospitalisée pour une endocardite bactérienne. Elle rentre à la maison et développe des nausées et vomissements. TTT : lisinopril, rifampicine et clarithromycine (?)

Creat et urée augmentées.

Urines : leuco, pas d'érythrocytes, FeNa 3,66%, fraction prot/creat (?) augmentée.

Quel Dx ?

- infection urinaire
- Syndrome néphrotique
- IR prérénale
- Néphrite interstitielle

Neuro. 106. Jeune femme, hospitalisée après accident de voiture. Après 6 heures elle développe un hemisindrome à droite, à l'examen clinique vous retrouvez ça (cf. photo)



Quel Diagnostic est le plus probable ?

- AIT
- Dissection carotidienne
- Hémorragie cérébrale
- Hématome sous-dural

110. Un enfant tombe à vélo et se casse une incisive (dent de lait). Son papa a amené la dent. Que faut-il faire?

- L'envoyer chez le dentiste, mais pas en urgence
- L'envoyer à l'hôpital central
- Toucher la dent le moins possible et l'envoyer chez le dentiste en urgence
- Mettre la dent dans une boîte à dent des urgences et l'envoyer chez le dentiste en urgence

115. Homme de 48 ans qui bénéficie d'un enregistrement cardiaque sous-cutané (un truc style pacemaker), qui doit faire un IRM du genou. Qu'est-ce qui est juste

- a. Le consentement du patient suffit
- b. Il faut arrêter le pace pendant l'enregistrement avec un aimant
- c. l'IRM est contre-indiqué car il risquerait d'effacer les données enregistrées par le pace
- d. Il faut vérifier les indications du fabricant et demander l'avis d'un cardiologue.

123. Un enfant de 21 mois, amené par ses parents pour toux, état fébrile, rhinorrhée, voix rauque depuis 2 jours. La toux s'est exacerbée et il a des bruits respiratoires. Son frère de 6 ans présente également un refroidissement. Aux urgences, il a 37.8, sat 96%, stridor inspiratoire. Fond de gorge légèrement érythémateux.

Quelle est la prise en charge.

- Intubation orotracheale
- Adrénaline inhalée et vapeur
- Antibiotiques et hospitalisation
- Bronchoscopie à la recherche d'un corps étranger
- Évaluation par scopie d'une sténose sous glottite

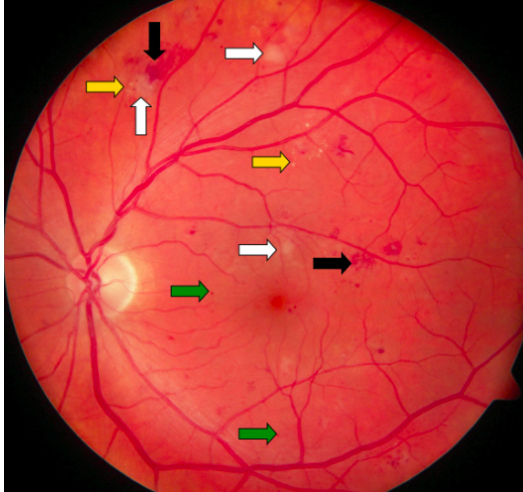
Xx. Homme de 80 ans chute et se rattrape avec la main.
(Rx face/profile)



- A. Fracture de l'avant-bras
- B. Fracture non déplacée du radius
- C. Fracture du radius et du scaphoïde
- D. Fracture du radius avec déplacement postérieur (Pouteau Colles)
- E. Fracture de radius avec déplacement palmaire (Smith)

Ophtalmo.

Xx. Femme de 21 ans qui vient pour sa première visite ophtalmologique dans le contexte de son diabète de type 1. Status: baisse de l'acuité visuelle bilat, pression intra-oculaire normales ddc, image de fond d'oeil (la même mais sans les flèches, et + discret, symétrique) Quel est le diagnostic?



- A. Iris bombé
- ☒ B. Rétinopathie proliférative
- C. Névrite optique bilatérale
- D. Oedème papillaire bilatéral
- E. Fonds d'oeil normaux

Jeune et DT1 mal contrôlée

Xx. Patiente vieille avec prurit vulvaire. Essai de TTT AB sans amélioration, s'empire sous corticoïdes locaux. Diabétique et obèse. Amélioration après application de yoghourt nature. Attitude

- A. Antimycotique PO
- B. Poursuite yoghourt local
- C. Meilleure hygiène intime
- D. Antiviral contre herpès local

Xx. Un homme de 92 ans, se présente aux urgences pour toux sèche, fièvre et baisse de l'état général depuis 24h. Un frottis de grippe est effectué qui revient positif. L'examen pulmonaire est normal. La radiographie (image qui ne montre pas de foyer pulm.). Attitude ?

- A. Rien
- B. Oseltamivir
- C. Ceftriaxone
- D. Aciclovir
- E. Co amox

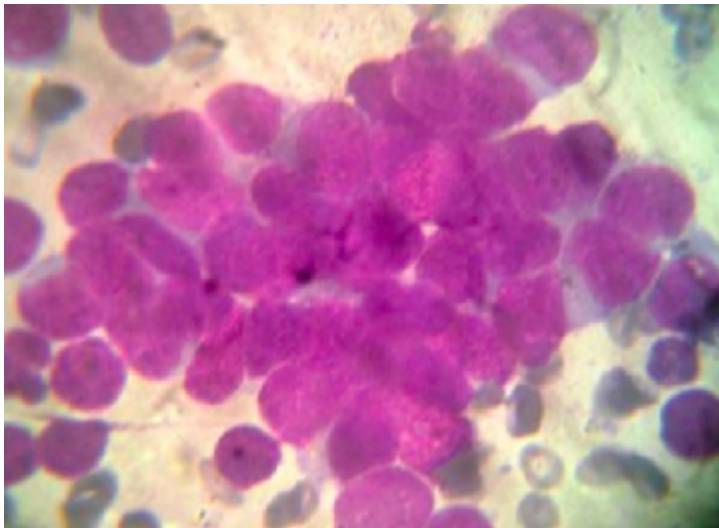
Xx. Chez un garçon de 14 ans on trouve une fièvre et une amygdalite caractérisée par la présence de membranes gris-blanchâtres, qu'on peut facilement détacher. Il a des lymphadénopathies généralisées, un exanthème maculo-papulaire, une augmentation des lymphocytes et monocytes dans la formule sanguine. Quel est le Dx le plus probable?

- a une leucémie aiguë
- b une infection à VIH
- c la diphtérie
- d la scarlatine
- e une mononucléose infectieuse

Cardio. Xx. Tableau clinique complexe pour finir par nous dire que QT long. Quel électrolyte a provoqué le QT long dans ce contexte ?

- K
- Na
- Mg
- Ca
- P

Xx. Jeune fille de 2 ans amenée par ses parents pour baisse de l'état général, très pâle . Sont inquiètes. Hb 90, LDH hauts. Imagerie: masse sus-rénale de 4cm rétro péritonéale. Biopsie moelle avec cellules rondes agglutinées (photo un peu comme ça qui voulait rien dire).



- sarcome d'Ewing
- Néphroblastome
- Neuroblastome
- Lymphome
- LMC

Xx. Patient jeune prenant un laxatif avec HTA résistante et hypoK. Résultat des examens :

- Rénine haute, aldostérone basse
- Rénine basse, aldostérone haute
- Rénine haute, aldostérone haute
- Rénine N, aldostérone basse
- Rénine N, aldostérone haute

Pneumo.

37. Un patient de 33 ans se présente chez un médecin généraliste pour une **dyspnée d'effort**, une **toux productive** depuis 3 semaines et des **poussées fébriles** depuis 4 semaines. Il se plaint en outre d'être **fatigué**. Il a depuis 4 ans une allergie aux pollens avec de **fréquentes crises d'asthme**. L'examen clinique démontre une obstruction bronchique. Le scanner thoracique montre des **bronchectasies** centrales contenant des impactions mucoides. Le labo montre: hémoglobine 117 g/l, leucocytes 12 G/l, **éosinophiles 3.5G/l**, **CRP 20 mg/l**, **IgE total 2800 kU/l**. Quel est le diagnostic le plus probable?

- A. Asthme allergique
- B. Pneumonie infectieuse
- C. Granulomatose avec polyangéite
- D. Déficit immunitaire commun variable
- E. Aspergillose broncho-pulmonaire allergique**

car IgE ↑ et Eosinophilie

74. Femme de 36 ans vient consulter pour sécheresse cutanée importante surtout au niveau des mains. Elle travaille dans une crèche et doit se laver les mains 15-20x par jour. Elle est connue aussi pour un trouble obsessionnel-compulsif pour lequel elle n'est pas traitée. A l'examen vous voyez une xérose importante de la peau des mains avec des fissures et une lichénification par endroit avec un érythème des dos des mains. Quel est le traitement le plus approprié ?

- A. Diphenhydramine topique
- B. Neomycin topique
- C. Lidocaïne topique
- D. Crème grasse à base de vaseline

Xx. Femme enceinte de 26 ans, IIIP, IIIG, se présente à **41 semaines 0/7 de grossesse**. Dans le passé, elle a eu un accouchement par voie basse et une césarienne. Bon état général, légères contractions, CTG dans la norme. **L'enfant se présente en position transverse**. Quelle démarche est la plus appropriée?

- A. Nouveau contrôle dans 2 jours
- B. Manoeuvre externe pour mettre le bébé en position céphalique
- C. Césarienne**
- D. Hospitalisation pour surveillance

VCE entre 36 et 37 SA

Xx. Un enfant de 8 ans reçoit un ballon de foot sur le thorax à la récré, il tombe et perd connaissance. Une réanimation cardio pulmonaire est initiée mais le patient décède, qu'est-il arrivé?

- a. Torsade de pointe
- b. Fibrillation Ventriculaire
- c. Pneumothorax sous tension
- d. Tamponade péricardique

commotio cordis:

L'enfant de 8 ans qui a reçu un ballon de football sur la poitrine et qui a perdu connaissance a probablement subi un commotio cordis. Il s'agit d'une arythmie ventriculaire, en particulier une fibrillation ventriculaire, provoquée par un traumatisme non pénétrant léger au niveau de la région précordiale, généralement causé par un objet dur et sphérique (comme un ballon de football). Cette arythmie est souvent fatale si une réanimation cardiorespiratoire immédiate n'est pas réussie.

a. Torsade de pointe : Cette arythmie est généralement associée à une prolongation de l'intervalle QT, ce qui n'est pas typique dans ce contexte.

b. Fibrillation Ventriculaire : C'est la réponse la plus probable car elle est directement liée au commotio cordis, une arythmie ventriculaire déclenchée par un traumatisme non pénétrant à la poitrine.

c. Pneumothorax sous tension : Un pneumothorax sous tension se manifeste par une déviation de la trachée et des bruits respiratoires diminués, ce qui ne correspond pas ici.

d. Tamponade péricardique : Une tamponade est souvent associée à une hypotension, des bruits cardiaques assourdis, et une distension des veines jugulaires (triade de Beck), mais elle n'est pas liée à un traumatisme direct et léger comme celui décrit.

Xx. Un homme de 50 ans consulte son médecin traitant pour une asthénie et des vertiges. ADP généralisées, splénomégalie. Labo : Hb=136 ; Créat=95
Electrophorèse des protéines : grand pic gamma -> IgM kappa=30.2

- A. MGUS
- B. Lymphome lymphoplasmocytaire (Waldenström)
- C. Leucémie myéloïde aiguë
- D. Leucémie lymphoïde chronique

Xx. Garçon de 6 ans en bonne santé habituelle et sans antécédent particulier est amené aux urgences parce qu'il a la sensation d'avoir le cœur qui « tape trop fort ». Dans l'après-midi il a joué au foot avec des copains et y est allé « un peu fort ».

A l'examen clinique, le garçon est anxieux et a une fréquence cardiaque à >220/min. Que faire?

- A. Rassurer et renvoyer à la maison: phénomène normal après le sport
- B. Benzodiazépine
- C. ECG et massage du sinus carotidien
- D.

Xx. Cas clinique d'un ileus, avec 2 images CT non-injectés qui montre une dilatation ++ de l'estomac. Quel est la première chose à faire?

- A. Sonde nasogastrique
- B. Laparotomie?
- C. Antibiotiques

Xx Homme de 25 ans qui se présente au cabinet pour des tâches douloureuse sur jambes qui sont apparues 1-2 semaines après une pharyngite. Il a pris des AINS ce qui a fait diminué transitoirement les lésions mais depuis qu'il a arrêté elles sont revenues. A l'examen clinique

Dermato.

vous trouvez ces lésions:

Quel est le diagnostique:

A. Erythème noueux



B. ...

Xx. Jeune homme qui se présente aux urgences pour un état fébrile au retour de voyage: il a fait trekk de plusieurs jours dans la région du Mékong. Il a des douleurs aux deux mollet et une conjonctivite (et probablement d'autres plaintes). Les CK sont augmentés (et je me rappelle plus des autres valeurs du labo). Quel est le Dx.

- a. Choléra
- b. Leptospirose
- c. Chikungunya

Xx. Une femme de 22 ans se présente aux urgences pour agression sexuelle. Elle s'est fait agressée par un homme dans l'entrée de son immeuble, et n'a pas osé se défendre. Il y a eu pénétration vaginale par le pénis (je vous jure c'était formulé bizarrement), et elle n'est pas sûre si il y a eu éjaculation. Que devez-vous faire:

- a. Dénoncer le cas à la police
- b. Demande un constat médico-légal
- c. Renvoyer la patiente à la maison

- d. Forcer la patiente à porter plainte

Xx. Une femme de 80 ans se plaint d'incontinence fécale. Vous apprenez que pour une constipation chronique, elle prend des laxatifs qui rendent ses selles très liquides. Cependant, même sans ce médicament, elle tâche ses sous-vêtements. Au toucher rectal vous sentez un bombement circulaire à l'effort de défécation. Quelle pathologie est le plus probablement à l'origine de ses symptômes?

- A. Prolapsus rectal
- B. Prolapsus anal
- C. Hémorroïdes de grade III
- D. Prolapsus péritonéal
- E. Rectocèle

Xx. Une femme de 27 ans présente depuis 24h se présente pour un écoulement vaginal abondant sans autre plainte (je crois): écoulement blanc au niveau du col, col et utérus indolore et mobilisable, masse annexielle droite palpée. Test de grossesse urinaire négatif. Anémie et tachycardie. Quel est la prochaine étape

- a. Dosage sanguin de β HCG
- b. Laparoscopie
- ☒ c. US endovaginal
- d. ...

Xx. vieille dame qui chute à domicile, la radiographie montre (faites abstraction que sur cette radio c'est pas une madame lol):



- a. Fracture du col
- b. Fracture de la diaphyse proximale
- c. Radio normale
- d. Fracture de la symphyse pubienne et de l'ischion

Xx. un homme de 73 ans souffrant d'athérosclérose généralisée est envoyé au service des urgences par son médecin traitant en raison d'une détresse respiratoire survenue subitement. A son admission il a le visage cyanosé, de la mousse sur la bouche, et ne peut plus répondre aux questions. TA de 240/140mmHg. Le malade doit être intubé. Les trop sont légèrement supérieures à la norme et cessent d'augmenter dès 3h. Quelle est le Dx le + vraisemblable?

- A. Myocardite fulminante
- B. Infarctus myocardique étendu
- C. Embolie pulmonaire
- D. Dissection de l'aorte
- E. Urgence hypertensive

Xx. Homme de 81 ans hospitalisé depuis 2 semaines en médecine interne en raison d'une insuffisance cardiaque décompensée. On a en outre posé au cours de son hospitalisation un dx de SMD. Trois nouveaux médicaments cardiaque ont été introduits. Une semaine après son arrivée à l'hôpital, le patient développe une septicémie par le cathéter, traitée par antibiotique de type bêta-lactame. Vous découvrez lors d'une visite une éruption cutanée maculo-papuleuse symétrique et asymptomatique du tronc et des grands plis. Étiologie de cette éruption?

- a. Exanthème para-infectieux
- b. paranéoplasique
- c. Dessèchement cut
- d. Exanthème médicamenteux
- e. Eczéma de contact généralisé

Xx. Femme de 72 ans qui se plaint d'incontinence urinaire d'effort. Hystérectomie il ya as, 3 accouchements. Pas de traitement habituel. Quelle est la prochaine étape

- a. Physiothérapie du plancher pelvien
- b. Médicament sympathomimétique
- c. Anti-cholinergique, ...

Xx. Patient-e? De xx ans qui se plaint d'incontinence fécale dans un contexte précis mais à l'anamnèse nous parle de souillure fécale habituel. Au TR: tonus sphinctérien diminué et à la poussée protrusion cylindrique de la muqueuse (pas sûre de cette formulation, mais c'était très bizarrement formulé). Quel est le diagnostic le plus probable:

- a. Prolapsus anal
- b. Entérocele
- c. Prolapsus rectal
- d. ...

Xx. Dans le cadre d'une étude sur les maladies coronarienne, il s'agit d'analyser les facteurs de risque ainsi que le déroulement de la maladie. Quel est le schéma d'étude le mieux adapté:

- a. Cas-contrôle
- b. Cohorte
- c. Randomisée contrôlée
- d. Écologie
- e. transversale

Xx. Homme de 55 ans jusque là sportif et en BSH, faiblesse générale et difficulté respiratoire à l'effort depuis 1 mois. Stase veineuse jugulaire à l'inspiration profonde, hépatomégalie, ascite, OMI. bandelette urinaire montre protéine ++. De quelle maladie s'agit-il:

- a. Syndrome budd-chiari
- b. Cirrhose hépatique
- c. Syndrome néphrotique
- d. Péricardite constrictive
- e. PBS

Xx. Patiente de 62 ans séjourne dans une chambre à 5 lits d'une service de chir, sur satus post résection colique (adénocarcinome). 10 jours après son admission, elle présente une toux et un EF qui conduisent au Dx de pneumonie à Legionelle. Quelle mesure épidémio prendre:

- a. Isoler la patiente
- b. Administrer un ttt antibio prophylactiques aux voisines de chambres
- c. Recherche legionella sur les frottis de surface de chambre
- d. Recherche legionella dans le'eau courant de le chambre
- e. Recherche legionella dans les frottis de enz des voisins de chambres

Xx. Jeune homme ayant un trauma x, radio de l'épaule montrant une fracture claviculaire communitive déplacée, avec atteinte nerveuse

- a. Ostéosynthèse
- b. Réduction fermée
- c. Réduction ouverte + ostéosynthèse
- d. Pas de différence entre ostéosynthèse et réduction fermée

Xx. femme avec endocardite à S. gallolyticus. Quelle investigation:

- a. Gastroskopie
- b. Coloscopie
- c. Us abdominal
- d. IRM cérébral

Xx. Dose maximale autorisée de rayonnement par année et par patient (pas sûre des valeurs retranscrite ici):

- a. Pas de limite
- b. 0.1mSv
- c. 1 mSv
- d. 6 mSV
- e. 10 mSV

Xx. Patient de 3 ans amené par son père car il est tombé de son vélo sans roulettes et s'est écrasé le visage contre un mur... Il a perdu une dent de lait au passage. Que faire ?

- A. L'envoyer en urgence chez le dentiste en touchant le moins possible à la dent
- B. Mettre la dent dans une "boîte d'urgence à dent" et l'envoyer chez le dentiste
- C. Lui remettre la dent en place puis l'envoyer chez le dentiste
- D. Rien
- E. L'envoyer chez le dentiste le lendemain

Xx. Jeune femme qui présente des symptômes de dépression depuis quelques mois. Elle souhaite commencer un traitement antidépresseur mais s'inquiète à l'idée de prendre du poids. Quel traitement est le plus adéquat dans cette situation?

- A. Citalopram
- B. Amitriptyline
- C. Phenelzine
- D. Sertraline
- E. Mirtazapine

Xx. Femme de 40 ans, d'origine congolaise a présenté il y a quelques temps de la toux, fièvre, ainsi que des céphalées et une perte de poids. Actuellement elle présente une hématurie. La prise de sang révèle éosinophilie, anémie et thrombocytopénie. De quoi souffre le plus vraisemblablement la patiente?

- A. Loa Loa
- B. Schistosomiase
- C. Taenia Solium
- D. Echinococcose

Xx. Jeune érythréen de 25 ans qui présente une toux avec expectorations et de la fièvre à 38° depuis quelques jours. Que fait on en premier lieu?

- A. Sérologie VIH
- B. Culture des expectorations
- C. Radio de thorax

D. Recherche de parasite dans les selles

xxx. Jeune homme de 25 ans qui suite à un accident de la voie publique reste bloqué dans sa voiture. Les secouristes constatent que son membre inférieur gauche est coincé entre l'airbag et le siège. Malgré cela le patient parvient à sortir de façon autonome de la voiture et se plaint uniquement de légère douleur et diminution de la sensibilité dans le pied gauche. Il est transporté aux urgences pour être examiné plus dans les détails. Aux urgences les paramètres vitaux sont dans la norme et le patient dit que actuellement sa douleur dans le pied gauche est légèrement augmenté et est associé à des paresthésies. A l'examen clinique du membre inférieur gauche, l'aspect est normal, les pouls périphériques sont palpables, on constate une hyposensibilité généralisé du pied gauche, ainsi qu'une brusque augmentation de la douleur dans le pied et dans le mollet gauche à la mobilisation passive de la cheville gauche. Vous devez penser à quel diagnostic en premier lieu? (P.s courage aux tessinois, vous allez tous passer).

- A. Embolisation distale d'un anévrisme poplité
- B. Rupture de malformation artério-veineuse
- C. **Syndrome des loges**
- D. Fracture type tile C
- E. Lésion du nerf fibulaire superficiel

Dans le contexte clinique que vous avez décrit, le diagnostic le plus probable est le syndrome des loges aigu (option C). Symptômes initiaux : Le patient présente une légère douleur et une diminution de la sensibilité dans le pied gauche après un traumatisme. Ce sont des signes précurseurs d'un syndrome des loges, bien que le tableau clinique complet puisse se développer rapidement.

Douleur aggravée : Le patient signale une augmentation de la douleur dans le pied gauche, ce qui est un symptôme clé du syndrome des loges. Cette douleur est souvent décrite comme disproportionnée par rapport à la blessure apparente.

Paresthésies et hyposensibilité : La présence de paresthésies (sensations anormales) et d'une hyposensibilité sont des signes de déficits neurologiques, qui sont fréquents dans le syndrome des loges aigu.

Douleur à la mobilisation passive : L'augmentation de la douleur à la mobilisation passive de la cheville gauche est un signe classique du syndrome des loges, car la douleur provient de l'étiement des muscles dans un compartiment sous pression.

Embolisation distale d'un anévrisme poplité (A) : Cela causerait des symptômes d'ischémie aiguë, mais la présence de pouls périphériques palpables rend ce diagnostic moins probable.

Rupture de malformation artério-veineuse (B) : Serait associée à une hémorragie et des symptômes différents.

Fracture type tile C (D) : Est une fracture pelvienne complexe et ne correspond pas aux symptômes cliniques décrits.

Lésion du nerf fibulaire superficiel (E) : Causerait des déficits sensoriels spécifiques, mais ne justifierait pas l'augmentation de la douleur à la mobilisation passive.

122. Jeune Érythréen de 25 ans, consulte sur conseil de son infirmière du foyer des réfugiés en raison d'une toux sèche et d'un état fébrile à 38.3°C (?) depuis 2-3 jours. Il n'a pas perdu de poids, mais vous le trouvez très maigre avec un BMI à 18.5 L'examen ORL et pulmonaire est sans particularité. Quelle est la suite de la prise en charge ?

A. CT thoracique.

B. Sérologie HIV.

C. Culture d'expectorations.

D. Radio thorax face/profil

36. Femme 50 année, a été hospitalisée pour une pneumonie pour laquelle elle a reçu la co-amoxicilline (x). A eu épisode de vomissement.

Sang :

Créat : 600

Urée : 20.1

Urines :

Leucos : chiffre pas retenu, dans les 70 environ mais au-dessus de la moyenne

Erythrocytes : 2 (N < 5)

Bactérie : aucune

FeNa : 3%

Créatinine urinaire : x

Protéines urinaires : 1.6

Quel est le diagnostic ?

A. Insuffisance pré-rénale

B. Glomérulonéphrite aiguë

C. Néphrite interstitielle

D. Syndrome néphrotique

Réponse probable : C (Fe Na > 1%, pyurie stérile)

Xx. Des parents vous amènent un garçon de 4 ans, inquiets car il leur semble que leur enfant louche.



Quelle est la meilleure prise en charge ?

- A. Faire une chirurgie strabologique en urgence
- B. Rassurer les parents car il s'agit d'un épicanthus**
- C. Envoyer aux urgences
- D. Instaurer un traitement par occlusion

98. Une mère vient en consultation dans votre cabinet de pédiatrie avec son enfant de 6 ans car celui-ci n'est toujours pas propre durant les nuits. Elle a déjà fait de nombreuses tentatives de traitement notamment en le réveillant durant la nuit mais rien n'y fait, il fait pipi au lit. Dernièrement, le petit bout de chou a refusé d'aller à une pyjama party pour l'anniversaire de son meilleur ami. Quelle est la meilleure suite de prise en charge?

- A. Effectuer un IRM du pelvis
- B. Effectuer une urétrocystoscopie rétrograde.
- C. Demander à la mère de remplir un journal des mictions et prendre un nouveau rendez-vous.
- D. Organiser une prise en charge chirurgicale.

Types K'

K' Quels vaccins sont recommandés à 14 ans?

- F. Hépatite B** *si pas encore vaccinée*
- G. DTP**
- H. Varicelle**
- I. Pneumocoque

K' Un patient cirrhotique, vient vous voir car il veut se faire opérer de son hernie ombilicale. Que risque-t-il ?

- A. Diminution de la fonction cardiaque
- B. Diminution de la fonction rénale
- C. Diminution de la fonction hépatique
- D. Hémorragie

64. Une jeune femme d'environ 83ans, prenant notamment de l'aspirine, se réveille à 3h du matin en raison d'un saignement nasal unilatéral qui ne s'arrête plus. Vous êtes dans l'ambulance avec la patiente (qui continue à pisser le sang) en route vers l'hôpital. Quelle est la chose à faire dans l'immédiat?

- A. Doser l'Hémoglobine
- B. Pincer le nez et appliquer de la glace sur la nuque
- C. Poser une voie veineuse périphérique
- D. Avertir l'ORL de garde
- E. Transfuser un culot erythrocytaire